



FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL	
CICLO	Desarrollo de Aplicacións Web
NOME E APELIDOS	Calos López Frieiro

REFLEXIÓNS

1. Como funciona segundo o documental o sistema sanitario americano? É universal?

O sistema sanitario estadounidense non é universal. Depende dunha combinación de seguros privados, programas gobernamentais como Medicare e Medicaid e unha porcentaxe significativa de persoas sen seguro. Os altos custos e a falta de cobertura para todos son problemas que destacan no documental Sicko.

2. No documental indican o custo do reimplante de dous dedos logo dunha amputación. Canto é? Investiga por internet o custo aproximado dos seguintes tratamentos en caso de non ter seguro:

- Operación de apendicite.
Entre \$10,000 e \$35,000
- Nacemento de fillo/a.
O custo medio dun parto pode ser de \$18,865.
- Escordadura de nocello.
Un escordadura de nocello sen seguro pode custar menos de \$500 para unha escordadura leve a moderado e hasta \$2,500.
- Bypass cardíaco.
A cirurxía de bypass cardíaco sen seguro pode custar entre \$70,000 y \$200,000.
- Tratamento quimioterapia.
O custo da quimioterapia sen seguro pode variar entre \$15,000 e \$200,000 o máis, dependendo do tipo de cancro e a duración do tratamento.

3. Como funciona / é financiado o modelo sanitario americano? Teñen todos os habitantes do país que pagar as cantidades anteriores?

O sistema de saúde dos Estados Unidos é complexo e está financiado mediante unha combinación de seguros privados, programas do goberno federal como Medicare e Medicaid e programas financiados en distintos estados:

Seguro privado: moitos estadounidenses teñen a súa atención sanitaria pagada polo seu empregador. Moitas veces inclúese como un beneficio adicional nos paquetes de traballo. Non obstante, non todos teñen esta sorte. Segundo a Oficina do Censo



dos Estados Unidos, en 2007 case 46 millóns de persoas nos Estados Unidos non tiñan seguro de saúde.

Medicare e Medicaid: o goberno dos Estados Unidos financia dous tipos de plans de saúde: Medicare e Medicaid. Están especialmente deseñados para persoas maiores, discapacitados, pobres e mozos.

Pago directo: os hospitais e os médicos deben atender aos que precisan axuda, pero moitas veces ao final do procedemento pídeselles aos pacientes os seus datos para poder enviarlles unha factura. O custo pode pagarse en prazos dependendo da súa situación económica.

En canto a se todos no país teñen que pagar as cantidades anteriores, a resposta é que depende. Non todos os residentes dos Estados Unidos teñen seguro de saúde, e aqueles que non o teñan poden afrontar altas facturas médicas se necesitan tratamento. Non obstante, existen programas de asistencia para aqueles que non poden pagar o seguro médico ou o custo do tratamento médico.

4. Como funciona o modelo europeo/español?

O sistema sanitario español, coñecido como Sistema Nacional de Saúde (SNS), é un dos mellores do mundo e ofrece unha cobertura sanitaria case universal a todos os residentes:

Cobertura universal: máis do 99% da poboación recibe asistencia sanitaria pública. O sistema garante unha cobertura case universal para todos os veciños.

Financiamento: máis do 70% do sistema sanitario está financiado con impostos públicos, o que representa aproximadamente o 11% do PIB. Os cidadáns que pagan a seguridade social teñen automaticamente dereito a utilizar o sistema sanitario español.

Organización: O sistema público de saúde organízase a nivel nacional e autonómico. O ámbito nacional é o responsable das leis e os regulamentos, e o ámbito autonómico, repartido por 17 comunidades autónomas, supervisa a administración local dos servizos sanitarios.

Seguro privado: é habitual que os residentes españois dispoñan dun seguro de saúde privado para complementar a cobertura sanitaria pública.

Especialidades médicas: se necesitas axuda médica especializada, como un dentista ou un profesional da saúde mental, quizais necesites utilizar un seguro médico privado.

5. Indica distintas características dos sistemas sanitarios dos seguintes países e indica, segundo as túas experiencias, cales están presentes no Sistema Nacional de Salud español.



MODELO CANADIENSE

Anotacións

Financiamento público: o sistema canadense financia principalmente a través de impostos e está dirixido polo goberno, o que significa que a asistencia sanitaria é universal e gratuíta no punto de uso para todos os cidadáns e residentes permanentes.

Cobertura universal: todos os residentes canadenses teñen acceso a unha ampla gama de servizos básicos de saúde, incluíndo visitas médicas, atención hospitalaria, servizos de emerxencia e algúns servizos especializados.

Atención primaria centralizada: a atención primaria está xestionada principalmente por médicos de familia, que actúan como primeiro punto de contacto dos pacientes e coordinan a atención médica necesaria con outros especialistas se é necesario.

Libre elección do médico: os pacientes poden escoller libremente o seu médico de familia e acceder a servizos médicos especializados segundo sexa necesario, aínda que poden enfrontarse a tempos de espera para determinados tratamentos non urxentes.

Diferenzas co modelo español

Sistema mixto: España ten un sistema sanitario mixto no que conviven o sistema público, financiado principalmente por impostos, e o privado, ao que se pode acceder a través dun seguro de saúde privado ou pagando directamente os servizos médicos.

Convivencia de provedores públicos e privados: aínda que o sistema público é accesible para todos os cidadáns e veciños, moitos optan por utilizar servizos privados para evitar tempos de espera ou acceder a servizos non cubertos polo sistema público.

Maior descentralización: a xestión sanitaria en España está descentralizada, sendo as comunidades autónomas as competencias da prestación dos servizos sanitarios e da planificación sanitaria nas súas respectivas rexións.

Ancha cobertura: o sistema sanitario español ofrece un amplo abano de servizos médicos gratuítos ou cun copagamento nominal, que inclúe atención primaria, atención hospitalaria, atención especializada e medicamentos, entre outros.

MODELO BRITÁNICO

Anotacións

Financiamento público: o NHS financia principalmente a través de impostos e está xestionado polo goberno do Reino Unido. A asistencia sanitaria é gratuíta no punto de uso para todos os residentes do país, independentemente da súa capacidade de pago.

Cobertura universal: todos os cidadáns británicos e a maioría dos residentes permanentes teñen dereito a unha ampla gama de servizos de saúde, incluíndo atención primaria, atención hospitalaria, servizos de emerxencia, atención especializada e medicamentos recetados.

Atención primaria centralizada: a atención

Diferenzas co modelo español

Centralización vs. Descentralización: mentres que o SNS do Reino Unido está centralizado baixo a autoridade do goberno nacional, o sistema español ten unha estrutura máis descentralizada, coa xestión da sanidade delegada nas comunidades autónomas.

Papel do sector privado: aínda que o NHS británico baséase principalmente no sector público, hai un sector privado que ofrece servizos de saúde adicionais, como consultas de médicos privados e tratamentos non cubertos polo NHS. En España, o sistema sanitario presenta unha convivencia máis acusada entre o sector público e o privado, apostando unha parte

primaria é ofrecida polos médicos de cabeceira, que son o primeiro punto de contacto dos pacientes e coordinan a atención médica necesaria, incluídas as derivacións a especialistas e hospitais. <u>Acceso equitativo:</u> o NHS baséase no principio de acceso equitativo á atención sanitaria, o que significa que se prioriza a necesidade clínica en lugar da capacidade de pago. Non obstante, os tempos de espera poden variar dependendo da demanda e da dispoñibilidade dos recursos.	importante da poboación polos servizos sanitarios privados. <u>Modelo de financiamento:</u> aínda que ambos os sistemas se financian en gran medida mediante impostos, o NHS británico depende máis do financiamento público directo, mentres que o sistema español inclúe unha maior participación do sector privado a través do seguro de saúde e dos pagos directos dos servizos médicos.
MODELO FRANCÉS	
Anotacións <u>Seguro de saúde universal:</u> Francia ten un sistema de seguro de saúde universal, no que todos os cidadáns e residentes legais teñen dereito a unha cobertura sanitaria, independentemente da súa situación laboral ou de ingresos. <u>Seguro de saúde obrigatorio:</u> todos os residentes en Francia están obrigados por lei a ter un seguro de saúde, xa sexa a través do sistema público (Seguro Obligatorio de Sanidade - Assurance Maladie) ou a través do seguro médico privado complementario (Mutuelles). <u>Financiamento mixto:</u> o sistema sanitario francés finánciase mediante impostos, cotizacións sociais e achegas directas dos pacientes, así como mediante primas de seguro médico complementario. <u>Liberdade de elección do médico:</u> os pacientes en Francia teñen a liberdade de elixir o seu médico xeral e especialistas, podendo acceder directamente aos especialistas sen necesidade de derivación previa.	Diferenzas co modelo español <u>Seguro de saúde complementario:</u> en Francia, a maioría da xente ten un seguro de saúde complementario que cobre os custos adicionais non cubertos polo seguro médico obrigatorio. En España, aínda que tamén existe a opción de contratar un seguro sanitario privado complementario, non son tan habituais como en Francia. <u>Organización e xestión:</u> mentres que o sistema sanitario francés está centralizado e organizado a nivel nacional, cunha importante implicación do goberno na regulación e no financiamento, o sistema español está descentralizado, tendo as comunidades autónomas unha gran autonomía na xestión e prestación dos servizos sanitarios. <u>Copago:</u> en Francia, os pacientes a miúdo teñen que pagar unha porcentaxe do custo dos servizos médicos e dos medicamentos receitados, aínda que estes custos adoitan ser reembolsados polo seguro de saúde. En España tamén hai algún copago, pero en xeral son máis baixos que en Francia e se aplican de forma máis limitada.

- 6. Logo de ver o documental e investigar sobre a sanidade en Estados Unidos, fai unha reflexión crítica sobre o modelo europeo de asistencia universal e**



solidario respecto ó modelo de capitalización. Inclúe tamén unha reflexión crítica sobre o propio documental.

O modelo europeo de asistencia sanitaria universal e solidaria supón un avance significativo cara á realización do principio de igualdade social e acceso equitativo aos servizos sanitarios. Este enfoque aposta pola xustiza social, a solidariedade e a redistribución dos recursos para garantir o benestar de toda a sociedade.

O sistema sanitario universal en Europa, financiado mediante impostos e que ofrece asistencia sanitaria gratuíta ou a baixo custo a todos os cidadáns, reflicte o compromiso da sociedade coa atención e protección dos seus membros máis vulnerables. Este enfoque recoñece a saúde como un dereito humano fundamental e non como un privilexio reservado a quen o pode pagar.

Por outra banda, o modelo de capitalización, como o que impera nos Estados Unidos, baséase na lóxica do mercado e prima o beneficio sobre as necesidades de saúde das persoas. Isto pode levar á mercantilización da atención sanitaria, onde o acceso aos servizos de saúde está determinado pola capacidade de pagar máis que pola necesidade médica.

Na miña opinión, o documental Sicko de Michael Moore serve como unha poderosa crítica ao sistema de saúde capitalista dos Estados Unidos. Moore destaca as inxustizas e desigualdades inherentes a un sistema con ánimo de lucro, onde as compañías de seguros e as corporacións farmacéuticas priorizan os beneficios sobre a saúde e o benestar das persoas. Ademais, o documental destaca como o sistema americano deixa a millóns de persoas sen unha cobertura sanitaria adecuada, o que provoca un sufrimento e unha traxedia evitables.

Michael Moore, pola súa banda, foi acusado de manipular datos e presentar casos anecdóticos para apoiar o seu argumento, o que podería debilitar a súa credibilidade como fonte de información obxectiva.

En conclusión, o modelo europeo de asistencia sanitaria universal e solidaria supón un avance cara á realización da xustiza social e da igualdade no acceso á atención sanitaria. O documental Sicko ofrece unha valiosa crítica ao sistema de saúde capitalista dos Estados Unidos, destacando a necesidade dun enfoque máis humano e solidario para garantir o dereito á saúde de todos.